RECOMENDACIONES TRAZADORAS

Guía de Práctica Clínica Hiperplasia Prostática Benigna

Recomendaciones clínicas trazadoras de la GPC Colombiana de Hiperplasia Prostática Benigna:

"Guía de práctica clínica Hiperplasia Prostática Benigna de la Sociedad Colombiana de Urología 2021", con adopción y adaptación institucional.

Recomendación 1: Evaluación diagnóstica

Se recomienda que, durante la evaluación diagnóstica de la hiperplasia prostática benigna, se identifiquen posibles diagnósticos diferenciales, como prostatitis y cáncer de próstata, y se defina el perfil clínico del paciente según la severidad de los síntomas urinarios, el grado de afectación de la calidad de vida, el riesgo de progresión y la presencia de complicaciones asociadas.

¿Cómo?

- Se sugiere evaluar de manera integral el tipo de síntomas urinarios bajos que presenta el paciente:

✓ **Síntomas de almacenamiento:** relacionados con alteraciones durante la fase de llenado vesical, incluyendo polaquiuria, urgencia urinaria, nocturia e incontinencia urinaria de urgencia.
✓ **Síntomas de vaciamiento:** asociados a dificultad en la salida de la orina, como disminución del calibre y fuerza del chorro urinario, intermitencia, pujo miccional, dificultad para iniciar la micción y sensación de vaciamiento incompleto.
✓ **Síntomas pos miccionales:** manifestados posterior a la micción, incluyendo goteo terminal y persistencia de sensación de vaciamiento vesical incompleto.

- Realizar una historia clínica completa para identificar posibles causas y comorbilidades relevantes, incluyendo enfermedades médicas y neurológicas, medicación actual, hábitos de estilo de vida y factores emocionales y psicológicos (especialmente si presenta nocturia).

- Aplicar cuestionario de síntomas validado como el International Prostate Symptom Score (IPSS) para objetivar y cuantificar los síntomas clasificándolos en leves, moderados o severos.

- La función sexual debe ser evaluada preferiblemente con cuestionarios validados como el índice internacional de función eréctil (IIFD).

- El examen físico debe enfocarse en la palpación abdominal hipogástrica para descartar globo vesical, exploración de genitales externos para descubrir obstrucciones al flujo de salida, exploración del área perineal para cribado de lesiones neurológicas, evaluación de los reflejos bulbocavernoso y anal superficial.

Ver Ruta Clínica Institucional

Recomendación 2: Realizar Tacto rectal

Se recomienda realizar tacto rectal como parte obligatoria del examen físico en la evaluación integral del paciente con sospecha de hiperplasia prostática benigna, ya que permite valorar características prostáticas, identificar hallazgos sugestivos de otras patologías (prostatitis – cáncer de próstata) y orientar la conducta diagnóstica y terapéutica.

¿Cómo?

- Se debe realizar a todos los hombres mayores de 50 años cada 2 años si no presenta elevación del antígeno prostático específico, o en pacientes mayores de 40 años con antecedente familiar o personal de cáncer de próstata.
- Se debe valorar el tamaño de la próstata, la definición de sus límites, consistencia, movilidad, la presencia de nódulos y si existe dolor a la palpación.

Ver Ruta Clínica Institucional

Recomendación 3: Exámenes iniciales

Se recomienda solicitar como exámenes iniciales uroanálisis, creatinina sérica, glucemia y PSA en la evaluación de pacientes con hiperplasia prostática benigna, con el fin de identificar infección urinaria, hematuria, alteraciones de la función renal y trastornos metabólicos que puedan agravar los síntomas urinarios.

¿Cómo?

- Dentro de los exámenes complementarios básicos, se recomienda solicitar un uroanálisis útil para evaluar la presencia de infección urinaria o hematuria como posibles complicaciones de la hiperplasia prostática benigna, prestando especial atención a la glucosuria.

- Solicitar creatinina sérica para evaluar la función renal, si se encuentra elevada, debe efectuarse una ecografía renal para descartar alteraciones asociadas.

- Evaluar la glucemia, ya que la presencia de hiperglucemia empeora los síntomas debido a la poliuria asociada.

La Sociedad Colombiana de Urología recomienda la realización del antígeno prostático específico en hombres mayores de 40 años con una expectativa de vida mayor a 10 años. Sin embargo, la adopción institucional aprobada por el consenso de especialistas en urología determina su realización en todos los hombres mayores de 50 años, o mayores de 40 años con antecedente familiar o personal de cáncer de próstata o con antígeno prostático específico previo elevado.

- ✓ Antígeno prostático específico es normal se realiza seguimiento anual.
- ✓ Antígeno prostático específico alterado, el seguimiento es cada 3 meses.

Ver Ruta Clínica Institucional

Recomendación 4: Exámenes complementarios

Se recomienda considerar diario miccional de 3 días, cuantificación del residuo postmiccional mediante ecografía y ecografía de vías urinarias en pacientes con síntomas moderados a severos, con el fin de evaluar poliuria, nicturia, riesgo de retención urinaria, volumen prostático y posibles complicaciones asociadas.

¿Cómo?

- Se recomienda el uso del diario miccional de tres para la evaluación de la poliuria y la nicturia.

- La cuantificación del volumen de residuo postmiccional es útil para identificar pacientes en riesgo de retención urinaria aguda, se obtiene por medio de ecografía transabdominal.

- La determinación del volumen prostático es importante cuando se va a realizar un tratamiento invasivo o iniciar tratamiento con inhibidores de 5-alfa reductasa.

- Se recomienda indicar ecografía de vías urinarias en pacientes con síntomas urinarios moderados a severos, ofrece datos como volumen prostático, evaluación de vías urinarias altas en caso de complicaciones y medición del residuo postmiccional.

Ver Ruta Clínica Institucional

Recomendación 5: ¿Cuándo remitir a urología?

El médico general debe considerar la remisión a urología en los siguientes casos:

- Síntomas que generan duda en el diagnóstico, cuando existan hallazgos como hematuria micro o macroscópica, estrechez uretral o sospecha de cáncer de vejiga/próstata.
- Pacientes con enfermedad neurológica, aquellos que hayan tenido cirugía pélvica radical previa o radioterapia pélvica, y pacientes con un residuo postmiccional mayor de 100 ml.
- Pacientes con procedimientos quirúrgicos previos fallidos, en este caso está indicado un estudio urodinámico ordenado por urología, para identificar si el problema es obstructivo o por hipoactividad del detrusor.

Ver Ruta Clínica Institucional

Recomendación 6: Exámenes complementarios POR ESPECIALISTAS

La GPC establece que los exámenes se enfocan en estudios funcionales

- La cistoscopia está indicada en el estudio de pacientes con hematuria, estrechez uretral o cáncer de vejiga, adicionalmente cuando se planea un manejo mínimamente invasivo o quirúrgico como parte de la planificación del procedimiento.
- Estudio urodinámico, específicamente los estudios de flujo-presión, útil para diferenciar la obstrucción de la hipoactividad del detrusor, condición que en la mayoría de los casos no mejora con el tratamiento quirúrgico.

Ver Ruta Clínica Institucional

Recomendación 7: Manejo conservador

Se recomienda manejo conservador y seguimiento periódico en pacientes con síntomas leves y no complicados

¿Cómo?

- El manejo conservador está indicado en hombres con síntomas no complicados y leves.
- El protocolo de seguimiento para estos pacientes debe incluir una consulta a los 3, 6 y 12 meses, y posteriormente de forma anual si no hay cambios.

- Según el consenso de urología, para pacientes con síntomas leves y antígeno prostático específico normal se indica seguimiento cada 6 meses; los pacientes con antígeno prostático específico elevado requieren seguimiento cada 3 meses evaluando progreso de los síntomas, siendo importante individualizar al paciente y sus manifestaciones clínicas.

Ver Ruta Clínica Institucional

Recomendación 8: Asesoría hábitos saludables

La asesoría en hábitos de vida es una parte fundamental del manejo conservador.

- Se debe instruir al paciente en la reducción de la ingesta de líquidos en momentos específicos como por la noche, suspendiendo la ingesta 2 horas antes de acostarse y reduciendo el total a 2 litros al día.

- Se recomienda reducir el consumo de sodio, evitar o moderar el consumo de cafeína y alcohol, y aumentar el consumo de frutas y verduras, especialmente verduras de hoja oscura.

- Instruir al paciente sobre técnicas que incluyen la doble micción, compresión uretral para evitar el goteo postmiccional, técnicas de distracción (compresión del pene, ejercicios respiratorios, presión perineal, ejercicios mentales) y reentrenamiento vesical (aguantar para aumentar capacidad vesical hasta 400 ml).

- Se debe tratar el estreñimiento y controlar el peso, ya que la obesidad predice una respuesta más pobre a las terapias estándar.

Ver Ruta Clínica Institucional

Recomendación 9: Tratamiento farmacológico

Se recomienda individualizar el tratamiento farmacológico en pacientes con hiperplasia prostática benigna según el síntoma del tracto urinario inferior predominante, la severidad clínica, el volumen prostático y el impacto en la calidad de vida del paciente.

- El tratamiento farmacológico de primera línea para síntomas moderados a severos pero próstata agrandada menor de 40 ml son los antagonistas alfa-1-adrenorreceptores como tamsulosina o silodosina.

- Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como finasteride o dutasteride, se deben usar en hombres con próstata agrandada mayor de 40 ml y alto riesgo de progresión, ya que reducen el riesgo de retención urinaria aguda y cirugía.

- Se debe ofrecer tratamiento combinado con un bloqueador alfa-1 y un inhibidor de la 5-alfa reductasa (tamsulosina/dutasteride) a hombres con síntomas moderados a severos y un mayor riesgo de progresión de la enfermedad, por ejemplo con volumen de próstata mayor de 40 ml, cuyo beneficio principal es prevenir la retención urinaria aguda y la cirugía a largo plazo.

- Se indica el uso de antagonistas de los receptores muscarínicos como tolterodina o solifenacina en hombres con síntomas de tracto urinario inferior moderados a severos que tienen principalmente síntomas de almacenamiento en la vejiga.

- No deben usarse antagonistas de los receptores antimuscarínicos en hombres con residuo postmiccional mayor de 150 ml, ya que se corre el riesgo de debilitar la contracción vesical, aumentar el residuo postmiccional a niveles peligrosos o desencadenar retención urinaria aguda.

- Se debe usar el tratamiento combinado de un bloqueador alfa-1 con un antagonista del receptor muscarínico (Tamsulosina + Solifenacina) en pacientes con síntomas moderados a severos si el alivio de los síntomas de almacenamiento ha sido insuficiente con la monoterapia, con beneficio principal en el control de la urgencia y frecuencia urinaria.

- Los inhibidores de fosfodiesterasa 5 se indican en hombres con síntomas moderados a severos con disfunción eréctil.

- Tener en cuenta contraindicaciones de los inhibidores de fosfodiesterasa: Uso concomitante de nitratos, uso de doxazosina o terazosina, angina inestable, infarto de miocardio reciente (menor de 3 meses), accidente cerebrovascular (menor de 6 meses), insuficiencia miocárdica NYHA mayor de 2, presión arterial mal controlada, insuficiencia hepática o renal significativa, y neuropatía óptica isquémica anterior con pérdida repentina de la visión.

- Los agonistas beta-3 como mirabegron, se recomiendan en hombres con síntomas moderados a severos que tienen principalmente síntomas de almacenamiento, mejorando los síntomas de vejiga hiperactiva incluyendo frecuencia miccional, urgencia e incontinencia urinaria de urgencia. Pero NO es de primera línea**

Ver Ruta Clínica Institucional

Recomendación 10: Manejo quirúrgico

Se recomienda considerar manejo quirúrgico en pacientes con hiperplasia prostática benigna complicada, incluyendo retención urinaria recurrente, hematuria refractaria, cálculos vesicales, dilatación del tracto urinario superior o falla renal. La elección de la técnica

quirúrgica debe individualizarse principalmente según el tamaño prostático y las características anatómicas del paciente.

- El manejo quirúrgico está indicado en pacientes con retención urinaria recurrente, hematuria refractaria, cálculos vesicales, dilatación del tracto urinario superior o falla renal.

- La elección de la técnica quirúrgica depende principalmente del tamaño de la próstata.

- Para próstatas menores de 30 ml y sin lóbulo medio, se ofrece la incisión transuretral de la próstata.

- Para próstatas de 30 a 80 ml, el estándar de oro es la resección transuretral de la próstata, ya sea monopolar o bipolar, siendo esta última preferible por su menor morbilidad perioperatoria.

- Para próstatas mayores de 80 a 100 ml, la prostatectomía abierta o la enucleación endoscópica son los tratamientos de elección.

Ver Ruta Clínica Institucional